TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

TEMA 15

Educación para la Salud. La Escuela como Promotora de la Salud y el Bienestar Emocional. Las Conductas y los Hábitos Saludables. Educación Afectivo Sexual. Prevención de las Adicciones. Actuación e Intervención del Educador o Educadora Social en el Desarrollo de la Educación para la Salud y Educación de los Sentimientos

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Educación Social (A2.2018)

Bloque: Materias Específicas

Tema Oficial: 15

Normativa y Planes Clave: Carta de Ottawa de Promoción de la Salud (OMS, 1986); LOMLOE 3/2020; Ley 17/2007 (LEA); Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía; III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA); Programa "Hábitos de Vida Saludable" de Andalucía (*Creciendo en Salud* y *Forma Joven*); Estrategia de Salud Mental de Andalucía; Instrucciones de 17 de septiembre de 2010.

Autores y Referentes: Michael Marmot (Determinantes sociales), Daniel Goleman (Inteligencia emocional), Rafael Bisquerra, Howard Gardner.

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 15

1. Introducción y contextualización en la Educación Social

2. Educación para la salud: Concepto, modelos y marco normativo

2.1. El concepto holístico de salud de la OMS y la Carta de Ottawa (1986)

2.2. La Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (SHE) y la Red Andaluza

2.3. Los determinantes sociales de la salud (Marmot): Equidad y salud comunitaria

3. La escuela como promotora de la salud y el bienestar emocional

3.1. La salud mental infantojuvenil en el sistema educativo: Ansiedad, depresión y autolesiones

3.2. Estrategia de Salud Mental de Andalucía y coordinación con las USMIJ

3.3. Educación de los sentimientos e inteligencia emocional (Goleman, Bisquerra)

4. Conductas y hábitos de vida saludables en el ámbito escolar

4.1. Alimentación equilibrada (dieta mediterránea) y prevención de la obesidad infantil

4.2. Actividad física, reducción del sedentarismo y descansos activos

4.3. Higiene del sueño y ritmos circadianos en la infancia y adolescencia

4.4. El Programa "*Hábitos de Vida Saludable*" en Andalucía (*Creciendo en Salud* y *Forma Joven*)

5. Educación afectivo-sexual integral

5.1. Superación del modelo biologicista hacia el enfoque bio-psico-social y afectivo

5.2. Autoconocimiento, consentimiento informado y prevención de ITS y embarazos no planificados

5.3. El impacto del acceso precoz a la pornografía en internet y deconstrucción de mitos

6. Prevención de las adicciones químicas y comportamentales

6.1. Adicciones con sustancia: Alcohol (*binge drinking*), tabaco/vapeadores, cannabis y fármacos

6.2. Adicciones comportamentales (sin sustancia): Apuestas online, videojuegos compulsivos y redes sociales

6.3. Niveles de prevención: Universal, selectiva e indicada (III Plan Andaluz sobre Drogas - PADA)

7. Actuación e intervención del educador o educadora social

7.1. Coordinación de las Asesorías *Forma Joven* en los IES

7.2. Dinamización de talleres de educación emocional y afectivo-sexual en el POAT

7.3. Intervención socioeducativa en adicciones y detección de malestar psíquico

7.4. Escuelas de Familias y trabajo en red comunitaria (SAS, USMIJ, CTA)

8. Conclusión

9. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 15

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

La **Educación para la Salud** ha experimentado una profunda transformación epistemológica en las últimas décadas. Ha superado la vieja concepción biomédica, restrictiva y biologicista —centrada exclusivamente en la prevención de enfermedades y el miedo punitivo— para consolidarse como un **proceso pedagógico integral, emancipador y comunitario orientado a la promoción del bienestar físico, mental y social**.

La escuela es el entorno privilegiado para consolidar estilos de vida saludables: es la única institución por la que transita el 100% de la población durante su periodo evolutivo más plástico. No obstante, la salud no depende únicamente de decisiones biológicas individuales; está profundamente condicionada por los **determinantes sociales de la salud (Michael Marmot)**: la pobreza, la precariedad habitacional, el nivel educativo de las familias y el entorno barrial inciden directamente en las tasas de obesidad infantil, salud mental precaria o adicciones juveniles.

Para el **Educador y la Educadora Social**, este ámbito es de una vigencia incuestionable. En un momento de alarma social por el incremento de autolesiones, depresión adolescente, ludopatía online y consumo precoz de pornografía, el educador social despliega una intervención integral: dinamiza la salud emocional en las aulas, lidera la asesoría confidencial para jóvenes (*Forma Joven*), previene adicciones y teje alianzas operativas entre la escuela, las familias y el sistema sanitario público andaluz.

2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: CONCEPTO, MODELOS Y MARCO NORMATIVO

2.1. El concepto holístico de salud y la Carta de Ottawa

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) definió la salud como:

> "*Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.*"

En 1986, la **Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud** fijó las cinco áreas de acción indispensables:

1. Construcción de políticas públicas saludables.
2. Creación de entornos que apoyen la salud (escuelas saludables).
3. Fortalecimiento de la acción comunitaria.
4. Desarrollo de habilidades personales a través de la educación.
5. Reorientación de los servicios sanitarios hacia la prevención.

2.2. La Red de Escuelas Promotoras de Salud (SHE)

Impulsada por la OMS, la Comisión Europea y el Consejo de Europa, promueve que los centros educativos no se limiten a "impartir charlas aisladas de salud", sino que configuren un **entorno físico y relacional protector**: comedores escolares sostenibles, patios dinámicos, clima de convivencia positivo y alianza estrecha con las familias.

2.3. Determinantes sociales de la salud (Michael Marmot)

Existe un estricto **gradiente social de la salud**: a menor nivel socioeconómico de la familia, mayor es la prevalencia de obesidad infantil, caries, sedentarismo, tabaquismo y patologías de salud mental. La Educación para la Salud en Andalucía debe ser, por tanto, una herramienta de **equidad social y compensación de desigualdades**.

3. LA ESCUELA COMO PROMOTORA DE LA SALUD Y EL BIENESTAR EMOCIONAL

3.1. Crisis de salud mental infantojuvenil

La Organización Mundial de la Salud alerta de que el 50% de los trastornos mentales del adulto debutan antes de los 14 años. En el ámbito educativo andaluz se constata un aumento de:

- Trastornos de ansiedad generalizada y ataques de pánico escolares.
- Episodios depresivos, apatía y anhedonia.
- **Autolesiones no suicidas (cortes, quemaduras)** como mecanismo disfuncional de alivio del dolor emocional.
- Conducta suicida e ideación autolítica (obligación de activar el Protocolo de prevención del suicidio de la Consejería de Desarrollo Educativo).

3.2. Estrategia de Salud Mental de Andalucía y coordinación con USMIJ

Articula la atención integral interdisciplinar entre los centros educativos y las **Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ)** del Servicio Andaluz de Salud (SAS), garantizando la continuidad pedagógica durante los tratamientos ambulatorios u hospitalarios.

3.3. Educación de los sentimientos e inteligencia emocional

Siguiendo las aportaciones de **Daniel Goleman y Rafael Bisquerra**, la educación emocional entrena competencias básicas para la vida:

- **Conciencia emocional:** Identificar y poner palabras al mundo afectivo propio.
- **Regulación emocional:** Tolerar la frustración, modular la ira y gestionar el estrés.
- **Autonomía emocional:** Construir un autoconcepto positivo no dependiente del juicio ajeno.
- **Habilidades socioemocionales:** Empatía activa y resolución dialogada de desacuerdos.

4. CONDUCTAS Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN EL ÁMBITO ESCOLAR

HÁBITOS SALUDABLES EN LA ESCUELA ANDALUZA

NUTRICIÓN EQUILIBRADA	ACTIVIDAD Y DESCANSO	BIENESTAR EMOCIONAL
• Dieta mediterránea	• 60 min diarios AF	• Rincón de la calma
• Menús escolares km0	• Desplazamiento act.	• Autoestima y afecto
• Fruta en recreos	• Higiene del sueño	• Prevención estrés

4.1. Nutrición y prevención de la obesidad infantil

Andalucía presenta una de las tasas de sobrepeso y obesidad infantil más elevadas de Europa. Se promueve el consumo diario de frutas y verduras frescas, el agua como única bebida en el centro y la eliminación de máquinas de venta de bollería industrial y bebidas azucaradas.

4.2. Actividad física y descansos activos

Fomento de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, pausas activas durante las clases lectivas y fomento de los caminos escolares seguros a pie o en bicicleta.

4.3. Higiene del sueño

El uso nocturno de pantallas (luz azul) retrasa la secreción de melatonina, provocando déficit crónico de sueño en escolares, somnolencia diurna y fracaso escolar. Se orienta a las familias para apagar dispositivos dos horas antes de dormir.

4.4. El Programa "*Hábitos de Vida Saludable*" de la Junta de Andalucía

- **Creciendo en Salud (0-12 años):** Centrado en alimentación sana, educación emocional y autocuidado.
- **Forma Joven en el Ámbito Educativo (Secundaria):** Asesorías de salud integral en los institutos sobre sexualidad, adicciones y salud mental.

5. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL INTEGRAL

5.1. Superación del modelo biologicista

La sexualidad no se reduce a la reproducción biológica ni al peligro del contagio: es una **dimensión humana central de placer, comunicación, afecto, identidad y ternura**.

5.2. Componentes de la educación afectivo-sexual

- **Consentimiento expreso y libre:** "*Solo sí es sí*". El respeto incondicional a los límites corporales del otro.
- **Prevención de ITS y embarazos no planificados:** Información rigurosa sobre métodos anticonceptivos y de barrera (preservativo).
- **Diversidad afectivo-sexual:** Aceptación de las orientaciones del deseo y de las identidades de género (Ley 4/2023 y Ley 8/2017 de Andalucía).
- **Deconstrucción del porno violento online:** El consumo prematuro de pornografía en internet distorsiona la sexualidad juvenil, normaliza la violencia contra las mujeres y fomenta expectativas sexuales irreales.

6. PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES QUÍMICAS Y COMPORTAMENTALES

TIPOLOGÍA DE ADICCIONES JUVENILES

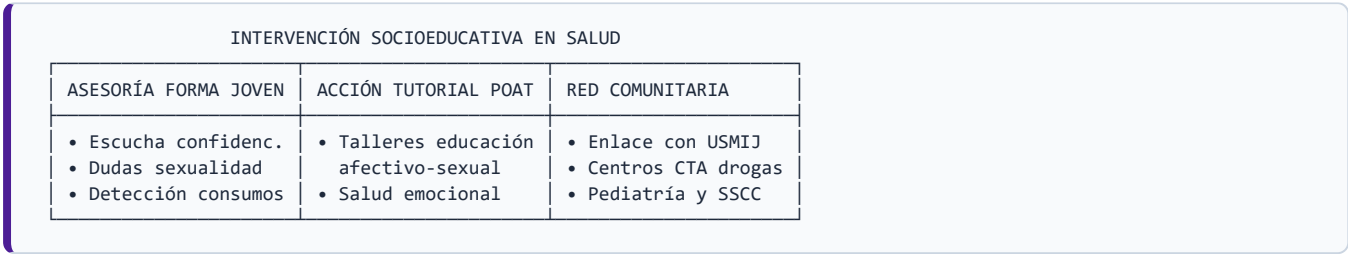
ADICCIONES CON SUSTANCIA	ADICCIONES COMPORTAMENTALES
• Alcohol (binge drinking)	• Juegos de azar y apuestas online
• Cannabis (falsas creencias inoc.)	• Videojuegos compulsivos (gaming)
• Vapeadores y tabaco	• Redes sociales y tiranía del like
• Psicofármacos sin prescripción	• Pornografía en internet

6.1. Niveles de prevención (III Plan Andaluz sobre Drogas - PADA)

1. **Prevención Universal:** Dirigida a todo el alumnado para retrasar la edad de inicio y fomentar habilidades de resistencia a la presión de grupo.
2. **Prevención Selectiva:** Dirigida a subgrupos en riesgo (fracaso escolar, familias con adicciones).
3. **Prevención Indicada:** Intervención intensiva con jóvenes que ya presentan consumos problemáticos o ludopatía incipiente.

7. ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL

En el marco de las **Instrucciones de 17 de septiembre de 2010**, el Educador Social despliega un rol asistencial y preventivo clave:



1. **Gestión de la Asesoría *Forma Joven*:** Punto de encuentro confidencial en el recreo donde los adolescentes consultan dudas íntimas sobre sexualidad, relaciones tóxicas, anticoncepción o consumos sin miedo a ser castigados.
2. **Talleres de Educación Emocional en el POAT:** Dinámicas de aula sobre gestión de la ansiedad, autocontrol de la ira y prevención de autolesiones.
3. **Intervención y acompañamiento en adicciones:** Detección de menores atrapados en las apuestas online o el cannabis, facilitando la derivación a los **Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)** de adicciones de Andalucía.
4. **Escuelas de Familias sobre Salud y Pantallas:** Asesoramiento a progenitores para establecer límites en el uso del móvil y reconocer señales de alarma en el estado de ánimo de sus hijos.

8. CONCLUSIÓN

La salud y el bienestar emocional no se logran prohibiendo o culpabilizando; se conquistan **capacitando a las personas para cuidar de sí mismas y de su entorno**.

El **Educador y la Educadora Social** humaniza la promoción de la salud en la escuela andaluza: no actúa como un médico distante, sino como un pedagogo de proximidad que enseña a nombrar las emociones, educa en la afectividad respetuosa, previene las adicciones y construye entornos comunitarios donde crecer con salud, dignidad y alegría de vivir.

9. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 15

Eje Temático	Normativa / Planes Clave	Conceptos e Implicación Práctica
Concepto de Salud	Carta de Ottawa (1986) • OMS (1948)	Estado holístico físico, psíquico y social; la escuela como entorno promotor de salud (SHE).
Determinantes Sociales	Michael Marmot	Gradiente social: el origen socioeconómico condiciona la salud; necesidad de equidad sanitaria.
Salud Mental Escolar	Estrategia de Salud Mental • SAS	Protocolo de prevención del suicidio, atención a autolesiones y derivación coordinada a USMIJ.
Inteligencia Emocional	Daniel Goleman • Rafael Bisquerra	Conciencia emocional, regulación, tolerancia a la frustración y habilidades prosociales.
Hábitos Saludables	Programa "Hábitos de Vida Saludable"	Modalidad *Creciendo en Salud* (Infantil/Primaria) y *Forma Joven* (Secundaria).
Afectivo-Sexual	Enfoque integral bio-psico-social	Consentimiento informado (*solo sí es sí*), anticoncepción, respeto LGTBI+ y desmontaje del porno.
Adicciones Químicas	III Plan Andaluz (PADA) • Centros CTA	Prevención del *binge drinking*, vapeadores y cannabis; superación de mitos de inocuidad.
Adicciones Comportamentales	Ludopatía online • Apuestas • Pantallas	Detección precoz de adicción a videojuegos y redes sociales; higiene digital doméstica.
Rol del Educador/a Social	Instrucciones de 17 de septiembre de 2010	Dinamizador de la asesoría *Forma Joven*, talleres en el POAT, escuelas de familias y red comunitaria.